MEDSINA 2027

MIND MAP : HYPERTENSION ARTÉRIELLE DE L'ADULTE (HTA)

Module de Cardiologie • Préparation Officielle Concours de Résidanat

GOOGLE DRIVE CLOUD

1 Définition & Diagnostic Positif

- Définition : PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg mesurée au cabinet médical lors d'au moins 2
- Confirmation indispensable avant de débuter un traitement (sauf HTA grade 3 d'emblée ≥ 180/110
- MAPA (Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle) : Moyenne 24h ≥ 130/80 mmHg, diurne ≥
- Automesure tensionnelle (AMT) : Règle des 3 (3 mesures matin, 3 mesures soir pendant 3 jours

2 Bilan Initial Systématique (Bilan de ret

- Bilan biologique initial :
- Glycémie à jeun, ionogramme sanguin (kaliémie obligatoire à la recherche d'hyperaldostéronisme
- Bilan lipidique à jeun (EAL : CT, HDL, LDL, Triglycérides).
- Bandelette urinaire ou rapport albuminurie/créatininurie (microalbuminurie).

3 Étiologies : HTA Essentielle vs Secondai

- HTA essentielle : 90-95% des cas, sujet > 40 ans avec ATCD familiaux, surpoids, syndrome
- HTA secondaire (5-10%) à évoquer chez sujet jeune (< 35 ans), HTA résistante ou sévère d'emblée :
- Rénovasculaire : Sténose de l'artère rénale (fibrodysplasie chez femme jeune, athérome chez
- Surrénalienne : Hyperaldostéronisme primaire (Adénome de Conn, hypokaliémie avec kaliurèse

CŒUR DU SUJET CLINIQUE

Hypertension Artérielle de l'Adulte (HTA)

Algorithme & Notions Haute Tombabilité

4 Stratégie Thérapeutique

- Mesures Hygiéno-Diététiques (MHD) : Toujours prescrites (régime hyposodé < 5-6 g NaCl/j,
- Traitement Médicamenteux de 1ère intention (Recommandations ESC/ESH) :
- Bithérapie fixe d'emblée chez la majorité des patients : IEC (ou ARA2) + Inhibiteur Calcique
- Monothérapie réservée : sujet très âgé fragile, ou HTA grade 1 à faible risque CV.

5 Pièges Concours & Vigilance Annales

- Piège Annales : Ne pas poser le diagnostic d'HTA sur une seule consultation sauf si HTA grade 3 (≥
- Piège Médicaments : Les bêtabloquants ne sont PLUS un traitement de 1ère intention dans l'HTA
- Piège Kaliémie : Les thiazidiques provoquent une hypokaliémie et une hyperuricémie (goutte), tandis

6 Points Clés Incontournables

- Seuil diagnostique au cabinet : ≥ 140/90 mmHg confirmé par MAPA (≥ 130/80) ou Automesure (≥
- Bithérapie fixe en un seul comprimé d'emblée recommandée en 1ère intention (IEC/ARA2 + IC ou
- Ne JAMAIS associer un IEC et un ARA2 (risque majeur d'insuffisance rénale aiguë et
- Hypokaliémie chez un hypertendu = Hyperaldostéronisme primaire (Adénome de Conn)

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES : Consultation: ≥ 140/90 mmHg; MAPA 24h: ≥ 130/80 mmHg; AMT: ≥ 135/85 mmHg

TRAITEMENT CLÉ : 1ère ligne: Bithérapie IEC/ARA2 + IC ou Diurétique thiazidique en monoprise; 2ème ligne: Trithérapie; 3ème ligne (résist